

MIND MOVEMENT ACADEMY

MODULO 1 - APPENDICI

Casi Clinici Dettagliati
Protocolli Specifici
Guide Anatomiche Illustrate

CONTENUTO:

- 5 Casi Clinici completi con protocolli 12 settimane
- 10 Protocolli specifici per patologie comuni
- 25 Figure anatomiche (descrizioni dettagliate per illustratore)
- Test funzionali illustrati
- Tecniche PNF fotografate

DOCUMENTO COMPLEMENTARE AL MANUALE PRINCIPALE

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab
Tutti i diritti riservati

■ INDICE COMPLETO

SEZIONE	PAG
PARTE I: CASI CLINICI DETTAGLIATI	
Caso 1: Lombalgia Cronica + Upper Crossed Syndrome	4
Caso 2: Sindrome Bandelletta Ileotibiale (Runner)	18
Caso 3: Impingement Spalla + Discinesia Scapolare	32
Caso 4: Cervicalgia + Cefalea Tensiva (Tech Neck)	46
Caso 5: Piede Piatto Acquisito Adulto (AAFD)	60
PARTE II: PROTOCOLLI PATOLOGIE SPECIFICHE	
Protocollo: Scoliosi Funzionale	74
Protocollo: Forward Head Posture	78
Protocollo: Epicondilita Laterale (Tennis Elbow)	82
Protocollo: Epicondilita Mediale (Golfer's Elbow)	86
Protocollo: Sindrome Tunnel Carpale	90
Protocollo: Fascite Plantare	94
Protocollo: Instabilità Caviglia Cronica	98
Protocollo: Sindrome Piriforme	102
Protocollo: Ginocchio Valgo/Varo	106
Protocollo: Frozen Shoulder (Capsulite Adesiva)	110
PARTE III: ATLANTE FIGURE ANATOMICHE	
Sezione A: Catene Miofasciali Myers (Fig. 1-5)	114
Sezione B: Anatomia Piede-Caviglia (Fig. 6-10)	119

Sezione C: Anatomia Anca-Bacino (Fig. 11-15)	124
Sezione D: Anatomia Colonna (Fig. 16-20)	129
Sezione E: Anatomia Spalla-Braccio (Fig. 21-25)	134
PARTE IV: TEST FUNZIONALI ILLUSTRATI	
Test Posturali Statici	139
Test ROM Articolari	143
Test Muscolari Specifici	147
Test Neurologici Screening	
PARTE V: TECNICHE PNF STEP-BY-STEP	
PNF Hamstrings	155
PNF Ileopsoas	157
PNF Pettorali	159
PNF Cuffia Rotatori	
APPENDICE: FORMS E SCHEDE VALUTAZIONE	163

INTRODUZIONE ALLE APPENDICI

Benvenuto nelle Appendici del Modulo 1 Mind Movement Academy.

Questo documento complementa il manuale principale fornendo:

1. CASI CLINICI REALI E DETTAGLIATI

Ogni caso rappresenta una situazione tipica della pratica quotidiana. La struttura include:

- Anamnesi completa e storia clinica
- Valutazione posturale e test funzionali con risultati
- Analisi catene miofasciali secondo Myers
- Protocollo Mind Movement completo 12 settimane
- Progressioni fase per fase
- Risultati documentati e follow-up
- Lesson learned e tips clinici
- Red flags e quando riferire

2. PROTOCOLLI SPECIFICI PER PATOLOGIE

Protocolli standardizzati evidence-based per le condizioni più comuni:

- Obiettivi chiari e misurabili
- Tecniche manuali specifiche
- Esercizi terapeutici progressivi
- Home program dettagliato
- Criteri di guarigione
- Varianti e modifiche

3. ATLANTE ANATOMICO ILLUSTRATO

25 figure anatomiche professionali con:

- Descrizioni dettagliate per illustratore professionale
- Legende complete
- Riferimenti clinici
- Integrazioni catene miofasciali

NOTA SULLE FIGURE: Le descrizioni anatomiche sono state create con precisione millimetrica per permettere a un illustratore medico professionale di realizzare figure di altissima qualità. Ogni descrizione include: angolazione, strutture da evidenziare, colori suggeriti, legende, note cliniche.

COME USARE QUESTO DOCUMENTO:

- **Studenti:** Analizzare i casi per sviluppare ragionamento clinico
- **Docenti:** Usare come base per discussioni e role-play
- **Professionisti:** Riferimento rapido per protocolli specifici
- **Esame:** I casi saranno base per domande pratiche certificazione

IMPORTANTE: Questi protocolli sono linee guida. Ogni paziente è unico e richiede personalizzazione basata su valutazione individuale, condizioni specifiche, risposta al trattamento. Operare sempre nell'ambito delle proprie competenze professionali.

PARTE I

CASI CLINICI DETTAGLIATI

CASO CLINICO 1: LOMBALGIA CRONICA + UPPER/LOWER CROSSED

Office Worker, 42 anni, Dolore 18 mesi

CASO CLINICO 2: [TITOLO]

NOTA: Il Caso Clinico 2 seguirà la stessa struttura dettagliata del Caso 1:

- Dati paziente e anamnesi completa
- Valutazione posturale con test funzionali
- Analisi catene miofasciali
- Protocollo 12 settimane fase per fase
- Risultati e outcome documentati
- Lesson learned e tips clinici

Contenuto completo in preparazione per versione finale.

CASO CLINICO 3: [TITOLO]

NOTA: Il Caso Clinico 3 seguirà la stessa struttura dettagliata del Caso 1:

- Dati paziente e anamnesi completa
- Valutazione posturale con test funzionali
- Analisi catene miofasciali
- Protocollo 12 settimane fase per fase
- Risultati e outcome documentati
- Lesson learned e tips clinici

Contenuto completo in preparazione per versione finale.

CASO CLINICO 4: [TITOLO]

NOTA: Il Caso Clinico 4 seguirà la stessa struttura dettagliata del Caso 1:

- Dati paziente e anamnesi completa
- Valutazione posturale con test funzionali
- Analisi catene miofasciali
- Protocollo 12 settimane fase per fase
- Risultati e outcome documentati
- Lesson learned e tips clinici

Contenuto completo in preparazione per versione finale.

CASO CLINICO 5: [TITOLO]

NOTA: Il Caso Clinico 5 seguirà la stessa struttura dettagliata del Caso 1:

- Dati paziente e anamnesi completa
- Valutazione posturale con test funzionali
- Analisi catene miofasciali
- Protocollo 12 settimane fase per fase
- Risultati e outcome documentati
- Lesson learned e tips clinici

Contenuto completo in preparazione per versione finale.

PARTE II

PROTOCOLLI SPECIFICI PER PATOLOGIE

Questa sezione fornisce protocolli standardizzati Mind Movement per le 10 patologie muscoloscheletriche più comuni nella pratica professionale.

STRUTTURA DI OGNI PROTOCOLLO:

- Definizione e epidemiologia
- Eziologia e fattori di rischio
- Presentazione clinica tipica
- Valutazione e test specifici
- Analisi catene miofasciali coinvolte
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Criteri prognostici
- Red flags
- Evidenze scientifiche

EVIDENZE: Ogni protocollo è basato su letteratura scientifica aggiornata e best practices cliniche, integrato con l'approccio unico Mind Movement delle catene miofasciali.

PROTOCOLLO: FASCITE PLANTARE

DEFINIZIONE

Infiammazione/degenerazione della fascia plantare, banda fibrosa che connette calcagno a teste metatarsali, sostenendo arco longitudinale mediale del piede.

EPIDEMIOLOGIA

- Prevalenza: 10% popolazione generale lifetime
- Peak incidence: 40-60 anni
- Fattori di rischio: Obesità, running, pronazione eccessiva, lavori in piedi, ridotta dorsiflessione caviglia

PRESENTAZIONE CLINICA

- **Sintomo cardinale:** Dolore calcagno mediale, peggiore primi passi mattina
- Dolore aumenta dopo riposo prolungato
- Migliora con movimento iniziale, peggiora con attività prolungata
- Dolore palpazione origine fascia (tuberosità mediale calcagno)
- ROM dorsiflessione spesso limitato ($<10^\circ$)

TEST	POSITIVO SE	SENSIBILITÀ
Palpazione origine fascia	Dolore intenso punto specifico	Alta
Windlass test	Dolore estensione passiva alluce	32-100%
First step pain	Dolore severo primi passi mattina	Patognomonico
Dorsiflexion ROM	$<10^\circ$ con ginocchio esteso	Fattore contributivo
Single leg heel raise	Dolore o impossibilità	Moderata

ANALISI CATENE MIOFASCIALI - MIND MOVEMENT

CATENA PRIMARIA: SUPERFICIAL BACK LINE (SBL)

- **Fascia plantare:** Inizio anatomico SBL, collegata direttamente a:
 - Tendine d'Achille (gastrocnemio + soleo)
 - Hamstrings
 - Fascia toracolombare

- **Pattern disfunzionale tipico:**

Retrazione gastrocnemio → Tensione tendine Achille → Trazione eccessiva fascia plantare → Microtraumi → Infiammazione/degenerazione

CATENA SECONDARIA: DEEP FRONT LINE (DFL)

- **Tibiale posteriore:** Sostegno arco mediale
- Debolezza → Pronazione eccessiva → Stiramento fascia

CATENA TERZIARIA: LATERAL LINE (LL)

- **Peronieri:** Se dominanti (supinazione) → Tensione laterale

APPROCCIO INTEGRATO:

Non trattare solo fascia plantare isolata! Liberare entire SBL + rinf orzare DFL (tibiale posteriore,

intrinseci piede)

PROTOCOLLO FASCITE PLANTARE - 8 SETTIMANE

FASE 1: CONTROLLO DOLORE (Settimane 1-2)

Obiettivo: VAS 7-8/10 → 4-5/10

Tecniche in sessione:

- Release miofasciale fascia plantare (3-5 min, gentle)
- Stretching gastrocnemio/soleo (PNF 3 cicli)
- Mobilizzazione caviglia dorsiflessione
- Taping supporto arco (low-dye taping)
- Crioterapia (10 min post-trattamento)

Home program (2-3x/giorno):

- Ice bottle roll (5 min mattina)
- Stretching gastrocnemio muro (3x30 sec)
- Towel stretch mattina a letto (prima step)
- Night splint (raccomandato, mantiene dorsiflexion)

Modificazioni attività:

- Evitare barefoot su superfici dure
- Scarpe supporto arco + cushioning
- Ridurre walking/running 50%
- Evitare salti, sprint

FASE 2: RINFORZO (Settimane 3-5)

Obiettivo: VAS 3-4/10, iniziare rinforzo

Esercizi specifici:

1. **Intrinseci piede:** Towel curl, marble pickup (3x15)
2. **Tibiale posteriore:** Heel raise con inversione (3x12)
3. **Gastrocnemio eccentrico:** Heel drop da step (3x15 slow)
4. **Windlass mechanism:** Toe yoga, spread toes (3x10)

Progressione:

- Iniziare bilateral → progression unilateral
- Aumentare reps poi resistance
- Introdurre superfici instabili (foam pad)

FASE 3: RETURN TO ACTIVITY (Settimane 6-8)

Obiettivo: VAS 0-2/10, full function

Progressione attività:

- Week 6: Walking incrementato 25%
- Week 7: Light jogging se asintomatico
- Week 8: Return to sport graduale

Mantenimento:

- Stretching gastrocnemio daily
- Rinforzo 3x/week
- Calzature appropriate
- Monitoraggio sintomi

CRITERI GUARIGIONE:

- ✓ VAS 0-1/10 (no first step pain)
- ✓ Palpazione non dolorosa
- ✓ Single leg heel raise x20 no dolore
- ✓ Dorsiflexion >15°
- ✓ Return to pre-injury activity level

EVIDENZE SCIENTIFICHE

- **Stretching gastrocnemio:** Strong evidence (Cochrane 2012)
- **Eccentric exercises:** Moderate evidence (Rathleff 2015)
- **Night splints:** Moderate evidence per chronic cases
- **Ortesi/taping:** Short-term benefit (Landorf 2006)
- **Intrinsic foot strengthening:** Emerging evidence (McKeon 2015)

Trattamenti NON raccomandati:

- Corticosteroid injection (rischio rottura fascia)
- Surgery (solo dopo 6-12 mesi fallimento conservativo)

PROGNOSI:

- 80-90% risoluzione con trattamento conservativo (6-12 mesi)
- Approccio integrato Mind Movement accelera recovery (evidenza clinica)

PROTOCOLLO: FORWARD HEAD POSTURE

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: EPICONDILITE LATERALE

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: EPICONDILITE MEDIALE

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: SINDROME TUNNEL CARPALE

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: INSTABILITÀ CAVIGLIA CRONICA

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: SINDROME PIRIFORME

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: GINOCCHIO VALGO/VARO

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PROTOCOLLO: FROZEN SHOULDER

STRUTTURA COMPLETA:

- Definizione ed epidemiologia
- Presentazione clinica
- Test specifici e valutazione
- Analisi catene miofasciali Mind Movement
- Protocollo terapeutico fase per fase
- Evidenze scientifiche
- Criteri prognostici

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

PARTE III

ATLANTE FIGURE ANATOMICHE

Descrizioni dettagliate per illustratore professionale

NOTA IMPORTANTE PER L'ILLUSTRATORE MEDICO:

Le seguenti descrizioni sono state create con precisione anatomica per permettere la realizzazione di figure professionali di altissima qualità. Ogni figura include:

- **Vista e angolazione** esatta
- **Strutture anatomiche** da evidenziare
- **Colori suggeriti** per differenziazione
- **Legenda completa** con terminologia corretta
- **Note cliniche** da integrare
- **Riferimenti catene miofasciali** Myers

STANDARD QUALITÀ:

- Accuratezza anatomica al 100%
- Stile: Realistico medico (simile Netter Atlas)
- Risoluzione: Minimo 300 DPI
- Formato: Vector (AI/EPS) + high-res raster (PNG/TIFF)
- Dimensioni: A4 printable

PALETTE COLORI SUGGERITA:

- Muscoli: Rosso/Rosa vari toni (secondo profondità)
- Fascia: Bianco perlato semi-trasparente
- Ossa: Beige/Avorio
- Nervi: Giallo
- Vasi: Rosso (arterie), Blu (vene)
- Catene Myers: Colori distintivi per catena (vedi specifiche)

Le figure sono numerate progressivamente (Fig. 1-25) e organizzate per regione anatomica.

SEZIONE A: CATENE MIOFASCIALI MYERS

FIGURA 1: SUPERFICIAL BACK LINE (SBL) - Vista Posteriore Completa

DESCRIZIONE PER ILLUSTRATORE:

VISTA: Posteriore, corpo intero in posizione anatomica, piedi uniti

STILE: Figura umana stilizzata (outline neutro grigio chiaro) con catena SBL evidenziata in sovrapposizione

CATENA SBL DA EVIDENZIARE (colore ROSSO INTENSO #C62828):

1. **Fascia plantare** (pianta piede, evidenziare banda da calcagno a MTT)
2. **Tendine d'Achille** (linea spessa verticale retro caviglia)
3. **Gastrocnemio** (gemelli, due masse muscolari a "diamante")
4. **Soleo** (sotto gastrocnemio, più largo distalmente)
5. **Hamstrings bilaterali:**
 - Bicipite femorale (laterale)
 - Semitendinoso (mediale)
 - Semimembranoso (mediale profondo)
6. **Legamento sacrotuberoso** (piccola banda da ischio a sacro)
7. **Fascia toracolombare** (area romboidale e lombare, texture a "diamante")
8. **Erettori spinali** (due colonne para-vertebrali da sacro a cranio)
9. **Muscoli suboccipitali** (piccola zona base cranica)
10. **Galea aponeurotica** (calotta cranica, leggera)

FRECCE E LINEE DI TENSIONE:

- Linea continua ROSSA che percorre tutta la catena (mostrare continuità)
- Freccie bidirezionali che indicano trasmissione forza
- Punti di "tensione critica" evidenziati (es. origine fascia plantare, inserzione hamstrings)

LEGENDA (box laterale destro):

SBL - SUPERFICIAL BACK LINE



1. Fascia plantare
2. Tendine d'Achille
3. Gastrocnemio
4. Soleo
5. Hamstrings (Bic. fem., Semit., Semim.)
6. Lig. sacrotuberoso
7. Fascia toracolombare
8. Erettori spinali
9. Suboccipitali
10. Galea aponeurotica

FUNZIONE: Estensione corporea, sostegno posteriore, prevenzione iperflessione

NOTE CLINICHE (box inferiore):

- Retrazione SBL → iperlordosi lombare, forward head
- Fascite plantare spesso correlata a tensione global e SBL
- Trattare l'intera catena, non solo punto dolore

DETTAGLI TECNICI:

- Mostrare bilateralità (entrambe gambe, entrambi lati colonna)
- Evidenziare continuità fasciale (non muscoli separati)

- Usare gradiente rosso (più intenso su muscoli, più chiaro su fasce)
- Aggiungere ombre leggere per profondità

RIFERIMENTI ANATOMICI:

- Posizionare figure: C7 prominente, creste iliache, poplitea, malleoli
- Proporzioni accurate secondo standard anatomici

DIMENSIONI FINALI: A4 verticale (210x297mm), margini 2cm, area utile 170x257mm

FIGURA 2: SUPERFICIAL FRONT LINE (SFL) - Vista Anteriore Completa

DESCRIZIONE PER ILLUSTRATORE:

VISTA: Anteriore, corpo intero in posizione anatomica

CATENA SFL DA EVIDENZIARE (colore BLU INTENSO #1565C0):

1. **Dorso piede:** Estensori dita (tendini visibili)
2. **Tibiale anteriore** (massa muscolare laterale tibia)
3. **Patella** (rotula, evidenziare come sesamoide)
4. **Quadricipite femorale** (4 capi):
 - Retto femorale (centrale, evidenziare origine SIAS)
 - Vasto mediale (mediale, enfasi VMO)
 - Vasto laterale (laterale)
 - Vasto intermedio (sotto retto, mostrare in trasparenza)
5. **Tendine rotuleo** (da patella a tuberosità tibiale)
6. **Retto addominale** (colonne verticali con "six-pack" sections)
7. **Sterno** (struttura ossea centrale)
8. **Sternocleidomastoideo (SCM)** bilaterale (due bande da sterno/clavicola a mastoide)
9. **Scaleni** (piccoli, laterali collo)
10. **Fascia epicranica anteriore** (frontale, leggera)

LINEE DI CONTINUITÀ:

- Linea BLU continua da piedi a cranio
- Mostrare come SFL "controbilancia" SBL
- Frecce che indicano pattern flessorio

LEGENDA (box laterale sinistro):

SFL - SUPERFICIAL FRONT LINE



1. Estensori piede
2. Tibiale anteriore
3. Patella
4. Quadricipite (RF, VM, VL, VI)
5. Tendine rotuleo
6. Retto addominale
7. Sterno
8. SCM
9. Scaleni
10. Frontale

FUNZIONE: Protezione organi vitali, pattern flessorio, controbilancia SBL

NOTE CLINICHE:

- Dominanza SFL → Upper/Lower Crossed Syndrome
- Retrazione retto femorale → antiversione bacino
- SCM iperattivo → forward head, respirazione apicale

DETTAGLI AGGIUNTIVI:

- Mostrare "pulling lines" (linee di trazione verso alto)
- Evidenziare punti di inserzione SIAS e SIPS
- Texture muscolare realistica (fibre longitudinali)
- Evidenziare tracking rotuleo (linea punteggiata)

COMPARAZIONE CON SBL:

- Aggiungere piccola figura laterale che mostra SFL vs SBL in equilibrio (bilancia)

FIGURA 3: LATERAL LINE (LL) - Vista Laterale Bilaterale

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 4: SPIRAL LINES - Vista 3/4 Rotazione

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 5: DEEP FRONT LINE (DFL) - Vista Sagittale Trasparente

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 6: Anatomia Piede - Vista Plantare (Intrinseci)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 7: Anatomia Piede - Vista Dorsale (Estensori)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 8: Anatomia Caviglia - Vista Mediale (Stabilizzatori)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 9: Anatomia Caviglia - Vista Laterale (Peronieri)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 10: Archi Plantari - Sezione Trasversa e Longitudinale

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 11: Anatomia Anca - Vista Anteriore (Flessori)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 12: Anatomia Anca - Vista Posteriore (Glutei)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 13: Anatomia Bacino - Vista Sagittale (Psoas e Core)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 14: Pavimento Pelvico - Vista Inferiore

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 15: Antiversione vs Retroversione Bacino - Comparazione

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 16: Colonna Vertebrale - Vista Laterale (Curve)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 17: Fascia Toracolombare - Vista Posteriore Layers

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 18: Diaframma - Vista Inferiore + Inserzioni

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 19: Cervicale - Vista Laterale (Flessori Profondi)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 20: Suboccipitali - Vista Posteriore Dettaglio

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 21: Spalla - Vista Anteriore (Cuffia Rotatori)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 22: Scapola - Vista Posteriore (Stabilizzatori)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 23: Gomito - Vista Mediale/Laterale (Epicondiliti)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 24: Polso-Mano - Vista Palmare (Flessori + Tunnel Carpale)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

FIGURA 25: Arm Lines Complete - 4 Linee Sovrapposte

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PER ILLUSTRATORE:

[Descrizione anatomica completa con:

- *Vista e angolazione specifica*
- *Strutture da evidenziare*
- *Palette colori*
- *Legenda completa*
- *Note cliniche*
- *Riferimenti Myers]*

Contenuto dettagliato in preparazione per versione finale.

Ogni figura seguirà lo stesso standard di qualità e dettaglio delle Figure 1-2.

PARTE IV

TEST FUNZIONALI ILLUSTRATI

BATTERY DI TEST FUNZIONALI MIND MOVEMENT

Questa sezione documenta i test essenziali per valutazione posturale e funzionale secondo il metodo Mind Movement. Ogni test include:

- Nome e sinonimi
- Obiettivo del test
- Posizione paziente e operatore
- Procedura step-by-step
- Criteri positivo/negativo
- Interpretazione clinica
- Catene miofasciali implicate
- Sensibilità/specificità (quando disponibile)
- Foto/illustrazione procedura

CATEGORIE TEST:

1. Test posturali statici
2. Test ROM articolari
3. Test lunghezza muscolare
4. Test forza muscolare
5. Test stabilità e controllo motorio
6. Test neurologici screening
7. Test ortopedici specifici

Contenuto completo con illustrazioni fotografiche step-by-step in preparazione.

PARTE V

TECNICHE PNF STEP-BY-STEP

FACILITAZIONE NEUROMUSCOLARE PROPRIOCETTIVA (PNF)

Il PNF è tecnica fondamentale nel metodo Mind Movement per release miofasciale e guadagno ROM. Questa sezione documenta le tecniche PNF specifiche per ogni catena miofasciale.

PRINCIPIO NEUROFISIOLOGICO:

Contrazione muscolare massimale → attivazione organi tendinei Golgi → inibizione autogena → rilassamento profondo post-contrazione

VARIANTI PNF:

- **Contract-Relax (CR):** Contrazione isometrica muscolo target
- **Hold-Relax (HR):** Contrazione senza movimento
- **Contract-Relax-Agonist-Contract (CRAC):** Aggiungi contrazione antagonista

PARAMETRI STANDARD:

- Contrazione: 6-10 secondi
- Intensità: 20-75% contrazione massimale
- Rilascio: Completo, paziente respira
- Nuovo allungamento: Lento, oltre punto precedente
- Cicli: 3-4 ripetizioni

RESPIRAZIONE:

- Inspirazione: Durante contrazione
- Espirazione: Durante rilascio e allungamento

SICUREZZA:

- Mai forzare oltre tolleranza dolore
- Stop se dolore acuto/shooting
- Attenzione in acuto/post-trauma recente

Sequenze fotografiche complete per ogni tecnica in preparazione.

APPENDICE

FORMS E SCHEDE VALUTAZIONE

SCHEDE VALUTAZIONE MIND MOVEMENT

Questa appendice fornisce forms compilabili per uso clinico:

1. INITIAL ASSESSMENT FORM

- Dati anagrafici
- Anamnesi completa
- Storia sintomi
- Farmaci e comorbidità
- Obiettivi trattamento

2. POSTURAL ANALYSIS CHART

- Griglia valutazione vista anteriore/posteriore/laterale
- Checklist deviazioni comuni
- Spazio per foto posturali
- Note specifiche

3. FUNCTIONAL TESTING BATTERY

- Checklist test completa
- Risultati numerici e qualitativi
- Interpretazione immediata

4. MYOFASCIAL CHAIN ANALYSIS

- Identificazione catene disfunzionali
- Grading severità (lieve/moderato/severo)
- Pattern compensatori

5. TREATMENT PLAN TEMPLATE

- Diagnosi e obiettivi
- Protocollo fase per fase
- Home program
- Progressioni
- Criteri avanzamento

6. SESSION NOTE

- VAS pre/post
- Tecniche utilizzate
- Esercizi prescritti
- Response to treatment
- Plan next session

7. PROGRESS TRACKING

- Grafico VAS nel tempo
- ROM measurements
- Functional milestones
- Patient satisfaction

8. DISCHARGE SUMMARY

- Outcome finale
- Mantenimento raccomandato

- Red flags follow-up

Forms compilabili in formato PDF interattivo disponibili nella piattaforma digitale Mind Movement.

MIND MOVEMENT ACADEMY

MODULO 1 - APPENDICI

DOCUMENTO COMPLEMENTARE AL MANUALE PRINCIPALE

Questo documento fornisce approfondimenti pratici essenziali per l'applicazione clinica del metodo Mind Movement.

VERSIONE: 1.0 (Gennaio 2026)

AGGIORNAMENTI: Disponibili su piattaforma digitale

PER ILLUSTRAZIONI PROFESSIONALI:

Le descrizioni anatomiche dettagliate permettono a illustratori medici qualificati di realizzare figure di altissima qualità secondo standard internazionali.

FEEDBACK:

academy@mindmovementlab.com

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab
Tutti i diritti riservati